

Os soros são usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo.

Características gerais das doenças imunopreveníveis

Considerando a história natural das doenças e o papel das vacinas no rompimento da cadeia de transmissão das doenças transmissíveis, seguem abaixo características gerais de doenças transmissíveis.

Quadro 3. Características gerais da tuberculose

Agente etiológico	Bacilo de Koch ou <i>Mycobacterium tuberculosis</i> e <i>M. Bovis</i> .
Reservatório	O indivíduo infectado, especialmente o bacilífero.
Fonte de infecção	O paciente que elimina grandes quantidades de bacilos no escarro (bacilífero)*. O gado bovino e outros mamíferos.
Modo de transmissão	De pessoa para pessoa, pelas gotículas de Wells eliminadas pela tosse de pacientes bacilíferos.
Período de incubação	Variável (entre a infecção e a doença pode ou não haver um período de latência de anos).
Transmissibilidade	Enquanto o doente eliminar os bacilos selvagens, ou seja, sem o efeito da quimioterapia.
Suscetibilidade	Universal (maior em desnutridos, alcoólatras e indivíduos imunodeprimidos).
Imunidade	A infecção, doença e a vacina BCG conferem imunidade relativa e de duração variável.

* Um paciente bacilífero (sem tratamento) infecta, nestas condições, aproximadamente entre cinco e dez pessoas por ano e se mantém bacilífero geralmente por dois anos – até a recuperação espontânea, morte ou cronificação, situação em que continuará eliminando bacilos por alguns anos. Iniciado o tratamento, o doente deixa de ser bacilífero em aproximadamente 15 dias.

Quadro 3.1. Vacina BCG (Bacilo de Calmette Guérin)

Tipo de vacina	Suspensão de bacilos atenuados.		
Número de doses	Uma (1) dose ao nascer, o mais precoce possível.		
Idade recomendada	Ao nascer, podendo ser realizada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Em adultos, apenas para contatos de hanseníase.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto. Não pode ser exposta à luz solar direta ou difusa , mesmo por curto período. Após diluição, a vacina só poderá ser utilizada dentro de um período de 6 horas.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	

Via de administração	Intradérmica, na altura da inserção inferior do músculo deltoide do braço direito. Para o comunicante de hanseníase, a dose extra deverá ser administrada 1 cm abaixo da cicatriz vacinal.
Dose	• Laboratório FAP: 0,1 mL via intradérmica. • Laboratório Serum Institute of India: 0,05 mL em crianças recém-nascidas até 11 meses e 29 dias e 0,1 mL para pessoas a partir de 1 (um) ano de idade, via intradérmica
Eficácia esperada	Cerca de 80% contra as formas graves, como meningite e tuberculose miliar.
Contraindicações	Contraindicações de caráter geral. Ressalta-se a imunodeficiência adquirida (Aids). Não é recomendável a aplicação da BCG em crianças com menos de 2kg de peso, devido à escassez do tecido dérmico.
Evolução normal da lesão	Lesão local, de evolução lenta e benigna, que se inicia por mácula, evolui para pápula, crosta e úlcera, durando em geral dois meses e deixando cicatriz plana. O enfartamento ganglionar axilar não supurado faz parte da evolução normal e desaparece espontaneamente sem tratamento.
Eventos adversos	O evento adverso resulta em geral de técnica incorreta: aplicação profunda ou inoculação de dose excessiva. As mais comuns são abscessos, úlceras $\geq$ a 1cm, gânglios flutuantes e fistulizados.(*)
Uso em comunicantes de hanseníase	Menores de 1 (um) ano de idade: Não vacinados: administrar 1 (uma) dose de BCG; • Comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal: não administrar outra dose de BCG. • Comprovadamente vacinados que não apresentem cicatriz vacinal: administrar 1 (uma) dose de BCG 6 (seis) meses após a última dose. A partir de 1 (um) ano de idade: • Sem cicatriz: administrar 1 (uma) dose; • Vacinados com 1 (uma) dose: administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a dose anterior; • Vacinados com 2 (duas) doses: não administrar outra dose de BCG.
Casos de RN nascidos de mãe bacilífera	Não administrar a BCG. Tratar a criança com medicação recomendada pelo protocolo da TB por 3 meses e após este período fazer o PPD. Se o resultado do PPD for $\geq$ 5mm, a quimioprofilaxia deverá ser mantida por mais três meses; caso contrário, interrompe-se o uso da medicação e vacina-se com BCG.

(*) Tratamento: isoniazida (hidrazida) – 10mg/kg de peso por dia até a regressão da lesão. O paciente com evento adverso deve ser avaliado pelo médico do Programa de Pneumologia Sanitária ao qual caberá instituir o tratamento.